

REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

SEMANA 5

LESIONES Y FRACTURAS DEL MMII - II



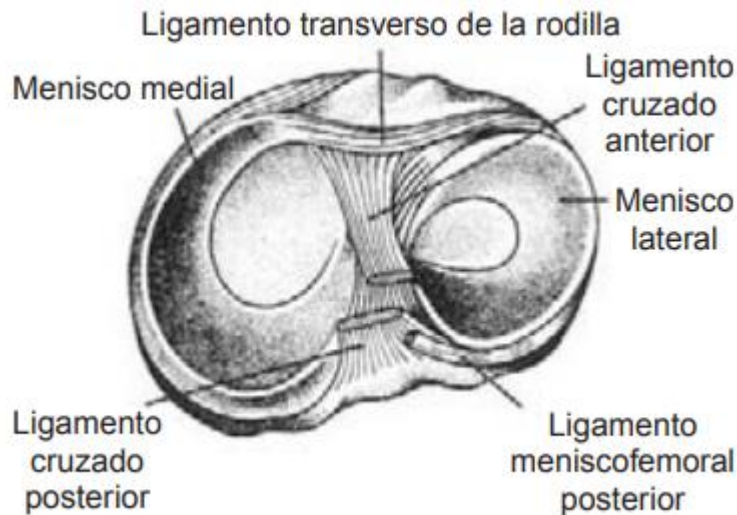
Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

MENISCOS

BASES ANATÓMICAS

- Son láminas semilunares de fibrocartílago que se apoyan en la cara articular de la tibia y absorben las cargas que pasan a través de esta articulación.
- Tienen forma de cuña y se insertan con firmeza en sus extremos a la región intercondílea de la tibia.
- El menisco medial tiene una forma de “C”, más ancho por detrás que por delante.
- El menisco lateral es prácticamente circular y se adapta a la forma, también circular, del cóndilo lateral de la tibia



FUNCIÓN

- Ayudan a la congruencia articular entre la epífisis distal del fémur y la proximal de la tibia.
- Transmitir a la tibia, de manera uniforme, las presiones que recibe, sobre todo en la posición de hiperextensión y apoyo de la rodilla, por lo que ofrecen también amortiguamiento.
- Estabilizan los movimientos articulares mediante el relleno del espacio muerto que existe entre los cóndilos y los platillos tibiales.
- Favorecen mecánicamente la lubricación intraarticular al permitir con sus desplazamientos una distribución eficaz del líquido sinovial.



MECANISMO DE LESIÓN

- Obedecen generalmente a un mecanismo rotacional de la rodilla cuando el miembro en apoyo se encuentra en semiflexión.
- El reborde del cóndilo femoral apoya directamente sobre el perímetro medial del menisco ejerciendo un cizallamiento, ya que lo somete a dos fuerzas de dirección contraria.
- En la periferia capsular, que es más extensa que la del menisco lateral, sufre una tracción.
- Las posiciones bruscas de la rodilla en varo o valgo suelen causar desgarros meniscales. Si el trauma en valgo es intenso, se puede producir una ruptura del menisco medial, del ligamento colateral medial y del ligamento cruzado anterior, entidad patológica conocida como “**Tríada de O’Donoghue**”.



MANIOBRAS DIAGNÓSTICAS: TEST DE MC MURRAY



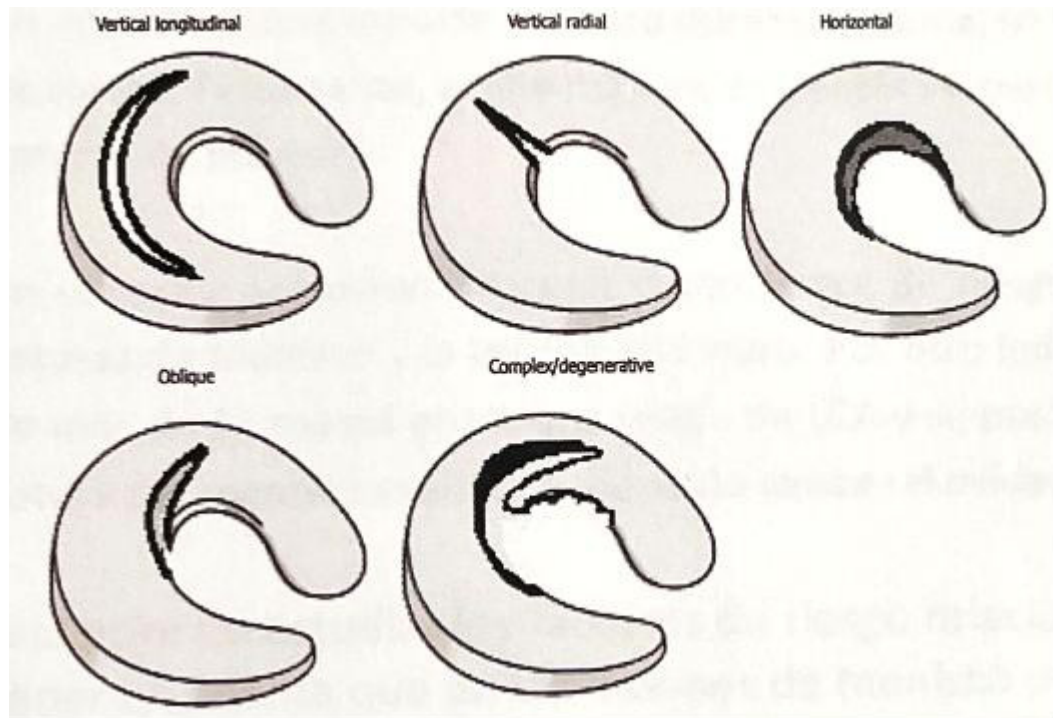
MANIOBRAS DIAGNÓSTICAS: TEST DE APLEY



MANIOBRAS DIAGNÓSTICAS: MANIOBRA DE STEINMAN



TIPOS DE LESIÓN MENISCAL



REHABILITACIÓN

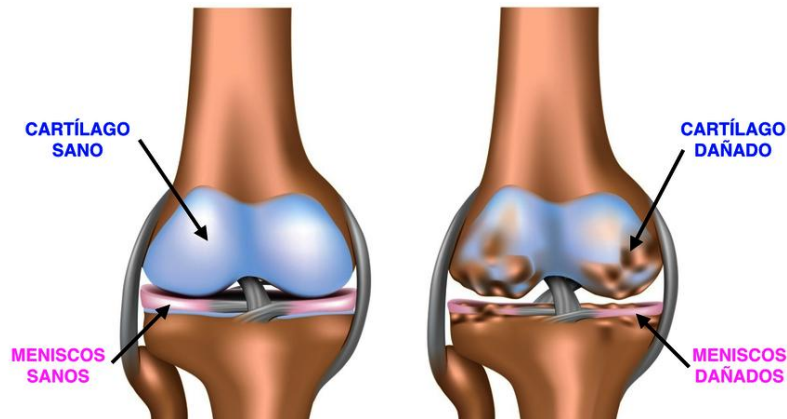
AGENTES FÍSICOS	TERAPIA MANUAL	EJERCICIOS TERAPÉUTICOS
• Ultrasonido • Corrientes estimulantes (TENS) • Corrientes interferenciales • Corrientes Rusas • Magnetoterapia • CHC – CF • Láser	• Tracción • Liberación miofascial • Estiramientos	• Ej. Isométricos (PT, Cuad. IQT, T. Sural) • Fortalecimiento progresivo • Resistencias moderadas (bandas elásticas) • Ej. Propioceptivo • (estabilidad estática y dinámica)



ARTROSIS DE RODILLA

DEFINICIÓN

- La artrosis de rodilla se caracteriza por el deterioro paulatino de este cartílago y conduce a la aparición de dolor con la actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como a deformidad progresiva de la rodilla.
- En general, es propia de personas mayores, aunque puede aparecer antes de los 50 años



CAUSAS

- Se cree que es la consecuencia de una suma de factores genéticos y ambientales.
- Entre los factores ambientales que aumentan el riesgo de padecer artrosis destacan la edad (a mayor edad más probabilidad de tener artrosis), determinadas ocupaciones o actividades laborales y el excesivo ejercicio físico.
- Otras veces la artrosis de rodilla se produce como resultado de una lesión o anomalía previa de la articulación tales como lesiones de los meniscos, de los ligamentos o del hueso articular, tras fracturas óseas intraarticulares.



Unidad de Rodilla

Artrosis

La artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que consiste en la alteración del cartilago, aunque también puede afectar al hueso, y finalmente a las partes blandas.



Edad: 75% de los pacientes mayores de 60 años



Sexo: más frecuente en mujeres



Illustration of a person sitting on the ground, holding their knee in pain, with red lightning bolts indicating discomfort.

1. Factores de riesgo

2. Síntomas

a Dolor e inflamación

b Deformidades

c Falta de movilidad

d Sobrepeso

3. Tratamiento

1. Conservador:
El ejercicio se considera un tratamiento muy eficaz en la artrosis.
→ Control de la dieta
→ Medicación contra el dolor y la inflamación
→ Complementos alimenticios

2. Acto terapéutico:
Infiltraciones articulares.
→ Corticoides
→ Ácido hialurónico
→ Factores de crecimiento
→ Células madre

3. Quirúrgico:
El tratamiento definitivo para la artrosis es la prótesis articular, ofreciendo muy buenos resultados.

SÍNTOMAS

- Dolor
- Rigidez
- Pérdida de la funcionalidad

SÍNTOMAS DE ARTROSIS DE RODILLA



The infographic is divided into two columns. The left column features an illustration of a man with a beard and a blue sweater, representing the 30-50 age group. The right column features an illustration of an older man with glasses, a beard, and a suit, representing the over 50 age group. Each column has a title in orange and a list of symptoms with checkmarks.

30 – 50 AÑOS

Sintomatología aparece en ejercicios de esfuerzo y alto impacto

- ✓ Dolor de rodilla
- ✓ Crujidos o ruidos al flexionar la articulación
- ✓ Inflamación de rodilla

MAYOR DE 50 AÑOS

Sintomatología aparece por actividades de menor intensidad y duración

- ✓ Dolor de rodilla al inicio de la actividad
- ✓ Rigidez al inicio de la actividad
- ✓ Inflamación de rodilla

DIAGNÓSTICO

- Se basa en los síntomas que explica el paciente junto con la exploración de la rodilla.
- En algunas ocasiones, si el paciente presenta hinchazón de la rodilla puede extraerse líquido articular para analizarlo y confirmar que las características son las típicas de la artrosis.
- La realización de radiografías también es útil para confirmar el diagnóstico ya que aparecerán los hallazgos típicos de la artrosis y permitirán establecer un pronóstico según la rodilla se encuentre más o menos desgastada.



REHABILITACIÓN

*AGENTES FÍSICOS	TERAPIA MANUAL	EJERCICIO TERAPÉUTICO
• Corrientes analgésicas (TENS -CIF) • Corrientes Rusas • Magnetoterapia	• Tracción • Liberación miofascial • Estiramientos	• Ej. Fortalecimiento (Cuadríceps, T. sural, Glúteos). • Ej. Propioceptivo (bases estables) • Acondicionamiento físico

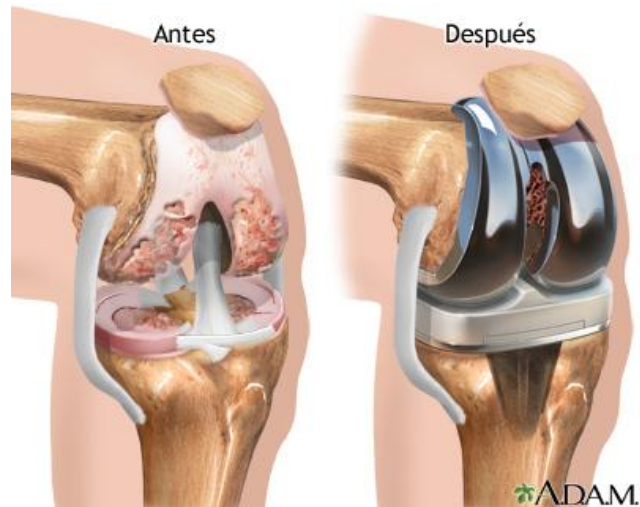
** La evidencia actual indica que el abordaje adecuado para la artrosis es el **ejercicio terapéutico acompañado de la terapia manual**. Sin embargo, se pueden recurrir a algunos A.F. para ayudar a la modulación del dolor en situaciones puntuales, pero el tratamiento no debe depender única ni mayoritariamente de los A.F.*



PRÓTESIS DE RODILLA

DEFINICIÓN

- Reemplazos de una o más partes de la articulación.
- Se clasifican en función de cómo se realice la sustitución de los huesos afectados, pero las más habituales son las conocidas como prótesis totales de rodilla (PTR).
- Las PTR se fijan a la tibia por medio de una bandeja tibial metálica y al fémur a través de unos cóndilos, también metálicos. Entre ambos se sitúa una pieza llamada inserto y fabricada de un plástico (polietileno) que facilita la articulación de fémur y tibia.
- Si el cirujano lo considera oportuno, también puede sustituir la parte articular de la rótula por un componente de polietileno.





TIPOS DE PRÓTESIS



Prótesis unicompartmental



Prótesis total de rodilla



Sistema de revisión de rodilla

FIJACIÓN

CEMENTADA	NO CEMENTADA
• Se utiliza cemento óseo alrededor de la prótesis que, al fraguar, sujeta el implante al hueso. • Proporcionar una sujeción inmediata que permite movilizar al paciente tan pronto como éste lo tolere, independientemente de su calidad ósea. • El cemento puede ir degenerando con el paso del tiempo.	• Las superficies de la prótesis se recubren de materiales porosos que imitan la textura del hueso y permiten que éste se vaya entremezclando con el recubrimiento, fijando así el implante. • Tiene la ventaja de ser una fijación más natural que la proporcionada por el cemento, pero su éxito depende de las condiciones previas del paciente.

PREPARACIÓN ANTES DE LA PRÓTESIS

- Manténgase activo y practique ejercicios de fortalecimiento orientados según la necesidad.
- Cuide su alimentación y procure mantener su peso dentro de los niveles saludables para su estatura y edad
- Control con agentes físicos necesarios para manejar los episodios inflamatorios
- No exponerse a situaciones que provoquen la complejidad del cuadro clínico



REHABILITACIÓN POST OPERACIÓN

- Ha de seguir el programa de rehabilitación ambulatoria indicado por su médico rehabilitador o fisioterapeuta. Caminar es un ejercicio excelente, aunque deberá usar muletas hasta que su médico o rehabilitador le recomiende lo contrario.
- Cuide la herida de acuerdo con las indicaciones dadas por el personal de enfermería del hospital.
- Siga la pauta de analgesia prescrita por su médico y cumpla escrupulosamente con la toma de medicamentos pautados.
- Evite sentarse en sillas bajas y utilice un alza en el inodoro.
- No se siente durante demasiado tiempo ni permanezca de pie de manera prolongada.
- No cruce las piernas ni se arrodille.
- Intente mantener una dieta correcta y un peso corporal adecuado.
- No conduzca ni realice actividades físicas intensas hasta que su médico se lo indique.





GRACIAS POR SU ATENCIÓN